Buổi 7 (BẢO VỆ & VIẾT: đạo đức, liêm chính, Phương pháp và Kết quả): Phiếu bài tập

Nền tảng Nghiên cứu Lâm sàng · Cấp độ 1 · Neudata · *#ClearDataClearImpact* · Tuần 7 · Thứ Bảy 12/12/2026 · trực tuyến, 19:30–22:30

Họ và tên: _____ **Khoa/Phòng:** _____

Gõ câu trả lời vào tệp Word này hoặc in bản PDF.

Phần	Nhiệm vụ	Khi nào
A	Tình huống liêm chính: xanh, vàng hay đỏ?	Cuối phần 7.2, hoàn thành ở nhà
B	Xây dựng đề cương 7: viết Phần 4 của đề cương (đạo đức, đăng ký, tính khả thi, kế hoạch công bố)	Trên lớp, trước giờ giải lao. Phần còn lại: ở nhà
C	**Thực hành bản thảo 1**: viết phần Kết quả cho câu hỏi FLUID-ICU của bạn	Sau phần 7.3, hoàn thành ở nhà

Các tệp bạn cần (gửi qua email): gói kết quả của câu hỏi bạn chọn (`Results_Pack_QN_VN.pdf`), mẫu bản thảo (`Manuscript_Template_IMRaD_VN.docx`), Bài báo 1 (Boulet 2024) và Bài báo 2 (Hyun 2023).

Phần A: Tình huống liêm chính: xanh, vàng hay đỏ?

Nhiệm vụ. Với mỗi tình huống, chọn một màu và viết một câu giải thích vì sao. Trên lớp, tự làm tình huống 1, 3 và 4, rồi bình chọn và chuẩn bị nêu lý do khi giảng viên mời. Tình huống 2, 5 và 6 làm ở nhà.

> **Chọn từ: XANH** = chấp nhận được như mô tả · **VÀNG** = chấp nhận được **chỉ khi** sửa hoặc công khai một điều gì đó (nói rõ điều gì) · **ĐỎ** = hành vi sai trái trong nghiên cứu hoặc vi phạm nghiêm trọng. Không được làm.

#	Tình huống	Màu	Vì sao?
1	Phiếu theo dõi dịch ngày 3 của ba người bệnh bị mất. Một bác sĩ nội trú "nhớ đại khái" cân bằng dịch của họ và nhập các giá trị đó để bộ dữ liệu được đầy đủ.		
2	Sau khi xem kết quả, nhóm nghiên cứu loại hai người bệnh có giá trị dịch "lạ" vì họ làm yếu mối liên quan. Bài báo không đề cập việc này.		
3	Trưởng khoa không tham gia nghiên cứu nhưng đề nghị đứng tên tác giả cuối "vì đây là khoa của tôi".		
4	(a) Một điều dưỡng dùng chatbot AI để cải thiện tiếng Anh cho phần Bàn luận do chính cô viết, kiểm tra từng câu, và nêu rõ điều này trong phần Lời cảm ơn. (b) Một đồng nghiệp tải bảng tính của nghiên cứu (có cả họ tên và mã số bệnh viện) lên một chatbot công cộng miễn phí và nhờ nó "chạy thống kê".	(a)	
		(b)	
5	Một nghiên cứu thuần tập trên người bệnh sepsis giống FLUID-ICU được công bố thành ba bài báo (tử vong, tổn thương thận cấp và thời gian nằm ICU) trên ba tạp chí, không bài nào nhắc đến các bài kia.		
6	Hai đoạn văn của một bài tổng quan đã công bố được chép nguyên văn vào phần Đặt vấn đề của bạn. Bài tổng quan được trích dẫn ở cuối đoạn, nhưng không có dấu ngoặc kép.		

Phần B: Xây dựng đề cương 7: đạo đức, đăng ký, tính khả thi và kế hoạch công bố

Nhiệm vụ. Điền phiếu này cho đề cương **của riêng bạn**. Trên lớp, giảng viên điền trước từng khối cho ví dụ xuyên suốt (nghiên cứu thuần tập hồi cứu về cân bằng dịch và tử vong 28 ngày ở người lớn bị sốc nhiễm khuẩn tại ICU của mình). Sau mỗi khối, bạn tự viết câu trả lời của mình và chuẩn bị đọc khi giảng viên mời. Nếu chưa xong trên lớp, làm tiếp phần còn lại ở nhà.

Câu trả lời của bạn sẽ trở thành Phần 4 của đề cương viết và slide 5 (đạo đức và tính khả thi) và slide 6 (kế hoạch công bố) của bài trình bày. Gửi email đề cương viết và 6 slide trước 19:30 thứ Bảy 19/12/2026, Buổi 8 (`Proposal_Brief_VN.pdf`).

B1. Đạo đức và sự đồng ý tham gia

Câu hỏi	Câu trả lời của bạn
Hội đồng đạo đức nào sẽ xét duyệt nghiên cứu? Bạn dự kiến hình thức xét duyệt nào (miễn xét duyệt / xét duyệt rút gọn / xét duyệt đầy đủ)? Hội đồng là bên quyết định.	
Người tham gia là ai, và họ có tự quyết định được khi đủ điều kiện tham gia không?	
Ai đồng ý tham gia (người bệnh / người đại diện hợp pháp / đồng ý trì hoãn / đề nghị miễn đồng ý)? Dùng sơ đồ quyết định về sự đồng ý trong ICU (slide Buổi 7).	
Ai lấy sự đồng ý, khi nào và ở đâu?	
Người tham gia có những nguy cơ và gánh nặng gì, và chúng được giảm thiểu thế nào?	
Nghiên cứu có cần đăng ký không? Thử nghiệm: có, trước người bệnh đầu tiên, trên ClinicalTrials.gov hoặc một sổ đăng ký khác của WHO. Tổng quan hệ thống: PROSPERO. Nghiên cứu quan sát: khuyến khích.	

B2. Bảo mật thông tin

Câu hỏi	Câu trả lời của bạn
Bạn sẽ thu thập những thông tin định danh trực tiếp nào (nếu có), và vì sao?	
Mỗi người bệnh sẽ được cấp mã nghiên cứu như thế nào?	
Tệp khóa (mã với danh tính) được lưu ở đâu, và ai được mở?	
Dữ liệu đã loại bỏ thông tin định danh sẽ được lưu ở đâu (được cơ sở phê duyệt, có mật khẩu bảo vệ)?	

B3. Kiểm tra tính khả thi (đánh dấu và nhận xét)

✓	Câu hỏi	Nhận xét
☐	**Thời gian:** tiến độ thực tế (hội đồng đạo đức 1–3 tháng, tuyển chọn, phân tích, viết bài)?	
☐	**Kinh phí:** đã nêu các khoản mục ngân sách (thời gian nhân lực, vật tư/xét nghiệm, phí công bố)?	
☐	**Nhân lực:** ai thu thập dữ liệu (ban đêm, cuối tuần), ai phân tích, có thời gian dành riêng không?	
☐	**Người bệnh:** năm ngoái khoa bạn có bao nhiêu người bệnh đủ điều kiện? Bạn có thể tuyển thực tế bao nhiêu người?	
☐	**Dữ liệu:** các biến chính có được ghi nhận thường quy không? Khả năng thiếu bao nhiêu?	

Rủi ro lớn nhất về tính khả thi: _____ Một cách khắc phục: _____

B4. Kế hoạch công bố (slide 6 của bài trình bày)

Mục	Câu trả lời của bạn
Tên đề tài tạm thời (từ PICO: thiết kế, I so với C, P, O, trong 10 đến 16 từ)	
Tạp chí mục tiêu (và một tạp chí dự phòng), đã kiểm tra trên DOAJ / NLM Catalog, biết rõ phí và giấy phép	
Hướng dẫn báo cáo (CONSORT / STROBE / STARD / PRISMA / SPIRIT / CARE)	
Có cần đăng ký không? Ở đâu? (từ B1)	
Các tác giả (đủ cả bốn tiêu chí ICMJE) và vai trò của họ (CRediT)	
Xung đột lợi ích và nguồn tài trợ cần công bố	
Tuyên bố chia sẻ dữ liệu (chia sẻ gì, ở đâu, với điều kiện gì)	
Hội nghị nơi bạn sẽ trình bày tóm tắt đầu tiên	

Khung tóm tắt có cấu trúc. Mỗi mục một dòng. Phần Kết quả là kết quả bạn *dự kiến sẽ báo cáo* (định dạng, không phải con số).

Mục	Một dòng
Đặt vấn đề	
Phương pháp	
Kết quả (dự kiến)	ví dụ "tử vong 28 ngày: n/N mỗi nhóm, RR (KTC 95%)"
Kết luận	Viết câu bạn sẽ dùng nếu kết quả dương tính, và câu bạn sẽ dùng nếu không.

Phần C: Thực hành bản thảo 1: phần Kết quả

Nhiệm vụ. Viết **phần Kết quả** cho câu hỏi FLUID-ICU của bạn, chỉ dùng gói kết quả của câu hỏi đó. Trên lớp, trước tiên cả lớp cùng viết phần Kết quả cho Q1 theo từng khối: với mỗi khối, bạn tự viết các câu, rồi chia sẻ khi giảng viên mời. Sau đó bắt đầu phần Kết quả cho câu hỏi của bạn. Hoàn thành ở nhà và nộp bài (xem "Sản phẩm cần nộp" bên dưới). Chỉ bắt buộc nộp phần Kết quả. Bạn có thể thêm các phần khác vào cùng tệp (`Manuscript_Brief_VN.pdf`).

Câu hỏi	Chủ đề	Gói kết quả
Q1	Cân bằng dịch dương đến ngày 3 và tử vong 28 ngày	`Results_Pack_Q1_VN.pdf`
Q2	Cân bằng dịch tích lũy và tổn thương thận cấp (AKI)	`Results_Pack_Q2_VN.pdf`
Q3	Cân bằng dịch tích lũy và số ngày không thở máy	`Results_Pack_Q3_VN.pdf`
Q4	Lactat ban đầu và tử vong 28 ngày, trường hợp đầy đủ so với quy gán đa bội	`Results_Pack_Q4_VN.pdf`
Q5	Cân bằng dịch và thời gian nằm ICU ở người sống sót	`Results_Pack_Q5_VN.pdf`

Bản nháp của lớp được gửi dạng PDF sau buổi học. Nếu bạn chọn Q1, hãy viết bằng lời của mình.

Danh sách kiểm tra phần Kết quả (mục STROBE)

Mỗi mục cần số liệu từ một chỗ cụ thể trong gói. Với Q1, số người tham gia nằm ở mục 2 của gói, sau đó là Bảng 1 (14), Bảng 2 (15), Bảng 3 và 4 (16) và Bảng 5 và 6 (17). Với Q2 đến Q5, mục cuối của gói, "Các mục STROBE mà gói này giúp bạn viết", cho biết bảng dùng cho từng mục.

- ☐ Người tham gia trước: số được thu nhận, được phân tích và bị loại, kèm lý do (13)
- ☐ Bảng 1 trong một hoặc hai câu có số liệu. Có báo cáo dữ liệu thiếu (14)
- ☐ Số kết cục ở mỗi nhóm, kèm mẫu số (15)
- ☐ Kết quả chính: ước lượng **thô và đã hiệu chỉnh** kèm khoảng tin cậy 95% (16)
- ☐ Các phân tích khác trong gói kết quả: độ nhạy, quy gán hoặc phân nhóm (17)
- ☐ Bảng 1 và một bảng hoặc hình chính tự đọc hiểu được
- ☐ Không bình luận ("vì", "gợi ý rằng") và không dùng từ nhân quả

☐ Tên bài dự kiến và câu công khai sử dụng AI

Lưu ý riêng cho từng câu hỏi

- **Q3:** số ngày không thở máy phân bố lệch và tính tử vong là 0.
- **Q4:** báo cáo cả ước lượng trường hợp đầy đủ và quy gán đa bội.
- **Q5:** chỉ người sống sót. Dùng trung vị và IQR.

Phương pháp (học ở 7.3, không bắt buộc nộp)

Nếu bạn nộp thêm phần Phương pháp, dùng mục 4 đến 12 của STROBE: thiết kế và bối cảnh, người tham gia, biến số, nguồn dữ liệu, sai lệch, cỡ mẫu ("mọi người bệnh đủ tiêu chuẩn trong nghiên cứu thuần tập đều được đưa vào"), phương pháp thống kê và dữ liệu thiếu. Thông tin có trong gói kết quả, `SAP_FLUID-ICU_VN.pdf` và `Data_Dictionary_VN.pdf`.

Sản phẩm cần nộp

Phần Kết quả của bạn, đặt tên `Surname_Firstname_Results_QN.docx`, gửi email cho người bình duyệt của bạn và giảng viên Vương Mỹ Lượng (myluong1710@gmail.com) **trước 23:59 Chủ nhật 20/12/2026 (giờ Việt Nam)**. Người bình duyệt của bạn được công bố cuối buổi học hôm nay.